NOTE DE CADRAGE

Formation AMaVi aux urgences

Se préparer, se coordonner et agir efficacement en situation sanitaire exceptionnelle.



VITAE

FORMATION SANTÉ

APPRENDRE
pour comprendre

FORMER
pour prendre soin

ÉVOLUER
pour se dépasser

EXPERTISE
HUMAIN
EXCELLENCE

INSPE – SORBONNE UNIVERSITÉ : MASTER 1 – MEEF PIF IFMN

- UE 1 : Concevoir et gérer un projet de formation
- Sous la guidance de M. G. SINGEOT

VITAE
FORMATION SANTÉ



Qui sommes-nous ?

VITAE Formation Santé est une structure dédiée à l'ingénierie et au développement des compétences des professionnels de santé.
Elle positionne la formation comme un levier stratégique au service de la qualité et de la sécurité des soins.

Origine et création

VITAE Formation Santé a été créée dans le cadre d'un travail universitaire, à l'initiative de Giovanni SILVETTI, étudiant en Master 1 MEEF PIF IFMN à l'INSPE – Sorbonne Université.
Elle fait suite à l'enseignement consacré à la conception et à la gestion de projets de formation.

Pourquoi ?

La création de **VITAE** repose sur le constat que les professionnels de santé évoluent dans des environnements de plus en plus complexes, nécessitant :

- Une adaptation constante des pratiques
- Une coordination renforcée des équipes
- Une capacité à agir efficacement en situation critique

Dans ce contexte, la formation apparaît comme un levier essentiel pour soutenir ces évolutions et garantir une réponse adaptée aux situations à forte criticité.

Notre vision

VITAE Formation Santé considère que le développement des compétences constitue un facteur déterminant pour :

- Garantir la qualité des soins
- Assurer la sécurité des patients
- Améliorer l'efficience des organisations de santé

Ainsi, la formation est envisagée comme un élément structurant du système de santé.
Elle constitue un investissement durable au service des professionnels et des patients.

Notre engagement

La structure s'engage à proposer des formations :

- Adaptées aux réalités du terrain
- Construites selon une démarche rigoureuse d'ingénierie pédagogique
- Centrées sur l'humain, la collaboration et la pratique professionnelle

La formation, c'est vital. Le développement des compétences, essentiel.

Giovanni SILVETTI
Étudiant en Master 1 MEEF PIF IFMN - INSPE – Sorbonne Université

Table des matières

1. DESCRIPTION DU PROJET 1

1.1. DESCRIPTION GLOBALE DU PROJET 1
1.2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 1
1.3. OBJECTIF DU PROJET 2
1.4. CONTEXTE 3
1.5. MODALITES 3
1.5.1. Durée, rythme et amplitude 3
1.5.2. Public ciblé 4
1.5.3. Modalités pédagogiques 4
1.5.4. Accompagnement 4
1.6. MATRICE SWOT 5

2. ORGANISATION DU PROJET 6

2.1. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 6
2.2. PLANNING – DIAGRAMME DE GANTT 7
2.3. MATRICE DES RESPONSABILITES – RACI 8
2.4. PLAN DE CHARGE 9
2.5. ANALYSE DES RISQUES 10

3. SCENARIO PEDAGOGIQUE 11

3.1. SCENARIO GENERAL 11
3.2. SCENARIO DETAILLE D'UNE PARTIE 14

4. VOLET TECHNIQUE 17

5. PROTOTYPES 19

5.1. SUPPORT DE PRESENTATION 19
5.3. OUTILS D'EVALUATION ET D'INTERACTION – LES QUIZ 21
5.3.1. Mentimeter 21
5.3.2. Google Form 23
5.3.3. Wayground 24
5.3.4. QRuiz 25
5.3.5. Klaxoon 26
5.4. SUPPORT DE SIMULATION 27

6. CONCLUSION 28

7. GLOSSAIRE 29

Utilisation de l'Intelligence Artificielle

Dans le cadre de la réalisation de ce travail, des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés de manière ponctuelle. Ils ont servi à :

- La relecture et la correction orthographique et syntaxique du document ;
- L'assistance à la structuration de certaines analyses, notamment l'analyse des risques et le plan de charge ;
- La création d'éléments graphiques (illustration de la page de garde, page de couverture et conception du logo).

L'ensemble du contenu a toutefois été vérifié, adapté et validé par l'auteur.

1. Description du projet

1.1. Description globale du projet

Ce projet consiste en la conception et la mise en œuvre d'une formation d'une journée (8h30), destinée aux professionnels de santé d'un service d'urgences, visant à renforcer leur préparation aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE), notamment dans le cadre des dispositifs ORSAN et plus précisément du volet AMAVI.

Cette formation se déroule en présentiel, en petits groupes, et repose sur une pédagogie active alternant apports théoriques, manipulation de matériel et simulation sur table. Elle s'inscrit dans un cadre institutionnel hospitalier, en lien avec les obligations réglementaires et les recommandations issues des retours d'expérience (RETEX).

Elle mobilise une approche interprofessionnelle, réunissant l'ensemble des acteurs du service (médicaux, paramédicaux et non médicaux), dans l'objectif d'améliorer la coordination, la réactivité et la sécurité des prises en charge en situation de crise.

1.2. Organisation pédagogique de la formation

La formation est structurée en plusieurs parties progressives, favorisant une montée en compétences des apprenants, allant des apports théoriques à leur mobilisation en situation simulée.

- **Partie n°1 : Théorie – ORSAN / AMAVI**
  - Définitions et concepts des situations sanitaires exceptionnelles
  - Cadre législatif et réglementaire
  - Organisation des SSE en France
  - Présentation des différents plans :
    - *ORSEC, ORSAN*
    - *AMAVI, NRB, EPI-CLIM, MEDICO-PSY, REB*
    - *Plan Blanc*
- **Partie n°2 : Déclenchement et organisation**
  - Procédure de déclenchement du volet AMAVI
  - Organisation du service en situation de crise
  - Organisation de l'hôpital
  - Rôle et fonctionnement de la cellule de crise
- **Partie n°3 : Rôles professionnels**
  - Identification des rôles et missions de chaque professionnel :
    - *Assistante médico-administrative (AMA)*
    - *Brancardier*
    - *Agents de service hospitalier (ASH)*
    - *Aides-soignants (AS)*

- *Infirmiers (IDE)*
- *Infirmiers en pratique avancée (IPA)*
- *Externes*
- *Internes*
- *Médecins*

♦ **Partie n°4 : Procédures et outils**
- Identification des patients :
  - *Bracelet SI-VIC*
  - *Bracelet AMAVI*
  - *Bracelet d'identité vérifiée*
- Fiche de tri médical
- Dossier papier :
  - *Observation médicale*
  - *Pancarte (soins, surveillance, prescriptions)*
  - *Demandes d'examens (radiologie, biologie)*
  - *Recueil de données administratives*

♦ **Partie n°5 : Mise en situation**
- Simulation sur table à partir de situations réalistes :
  - *Explosion dans le métro*
  - *Fusillade en gare*
  - *Déraillement de tramway*
  - *Effondrement d'immeuble*
- Réunion-bilan de la simulation

1.3. Objectif du projet

Ce projet a pour but de concevoir une formation qui sera destinée aux professionnels de santé, plus précisément d'un service d'urgence. Visant à améliorer leur préparation face aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE), en particulier dans le cadre des dispositifs ORSAN et AMAVI.

Plus précisément, cette formation a pour finalité de permettre aux apprenants de :
- Expliquer les principes du plan ORSAN et du dispositif AMaVi
- Analyser et adapter l'organisation face à une situations sanitaires exceptionnelle (SSE)
- Se positionner dans l'organisation lors d'un déclenchement AMaVi
- Expliquer son rôle et celui des autres professionnels lors d'un AMaVi
- Appliquer les procédures spécifiques à un AMaVi (tri, identification, organisation)
- Analyser une situation complexe en équipe et proposer des actions adaptées

Au-delà de l'acquisition de connaissances, ce projet vise à sécuriser la prise en charge des patients en contexte de crise, en renforçant la réactivité, la coordination et l'efficacité collective des équipes d'urgences.

1.4. Contexte

Ce projet s'inscrit dans le milieu hospitalier, plus précisément au sein d'un service d'urgences, confronté à la nécessité de se préparer aux situations sanitaires exceptionnelles, telles que les attentats, catastrophes ou accidents collectifs.

Il répond à un double constat :

- Une méconnaissance des dispositifs ORSAN et AMAVI par les professionnels.
- Des difficultés organisationnelles en situation de crise : se repérer dans le service (son rôle, ses missions), coordonner les actions, gérer le stress.

Ce besoin est renforcé par :

- Des obligations réglementaires nationales imposant la mise en œuvre de ces plans.
- Des RETEX mettant en évidence des axes d'amélioration.
- Un turn-over important du personnel, nécessitant des formations régulières.

L'enjeu est de permettre aux équipes d'être rapidement opérationnelles en situation de crise, tout en garantissant une prise en charge sécurisée des patients. De plus, elle a aussi une dimension pluridisciplinaire essentielle, permettant à chaque professionnel de comprendre le rôle des autres et de mieux interagir, afin d'améliorer la coordination globale.

1.5. Modalités

Cette formation repose sur une approche immersive, intégrant des simulations réalistes inspirées de situations concrètes. Elle adopte une dimension interprofessionnelle, en reproduisant le travail en équipe réelle afin de favoriser la coordination entre les différents acteurs.

Les participants utilisent du matériel concret, comme les bracelets d'identification ou les dossiers papier, ce qui renforce l'ancrage dans la pratique. Des outils directement transférables, tels que des fiches réflexes, sont également proposés pour faciliter l'application sur le terrain.

Enfin, elle permet de travailler à la fois la gestion du stress et la coordination, deux éléments essentiels en situation sanitaire exceptionnelle.

1.5.1. Durée, rythme et amplitude

La formation est organisée sur une durée d'une journée (de 8h à 18h, comprenant une heure de pause déjeuner), avec des sessions répétées afin de s'adapter aux contraintes de planning du service. Les participants sont répartis en petits groupes de 5 à 6 personnes, idéalement issus de professions différentes, ce qui permet de favoriser les échanges et la participation active.

Enfin, la formation est directement intégrée au planning du service, afin de garantir la continuité des soins tout en facilitant l'accès à la formation pour l'ensemble des professionnels.

1.5.2. Public ciblé

Professionnels de la santé :

- Médical : médecins, internes, externes
- Paramédical : Infirmiers, Aides-soignants
- Non médical : Agents de service hospitalier, Brancardiers, Assistante médico-administrative, Agent de sécurité.

1.5.3. Modalités pédagogiques

- Apports théoriques (diaporama interactif)
- Travaux en groupe
- Quiz
- Simulation sur table
- Manipulation de matériel réel
- Débriefing structuré (réflexif)

1.5.4. Accompagnement

- Encadrement par des formateurs
- Supports pédagogique remis :
  - Powerpoint
  - Fiche réflexe
  - Bracelets
  - Dossier papier
- Accompagnement pendant les simulations (guidage et débriefing)
- Support organisationnel :
  - Planification adaptée au service.
- Possibilité de formation régulière (turn-over) :
  - Une fois par mois minimum.

1.6. Matrice SWOT

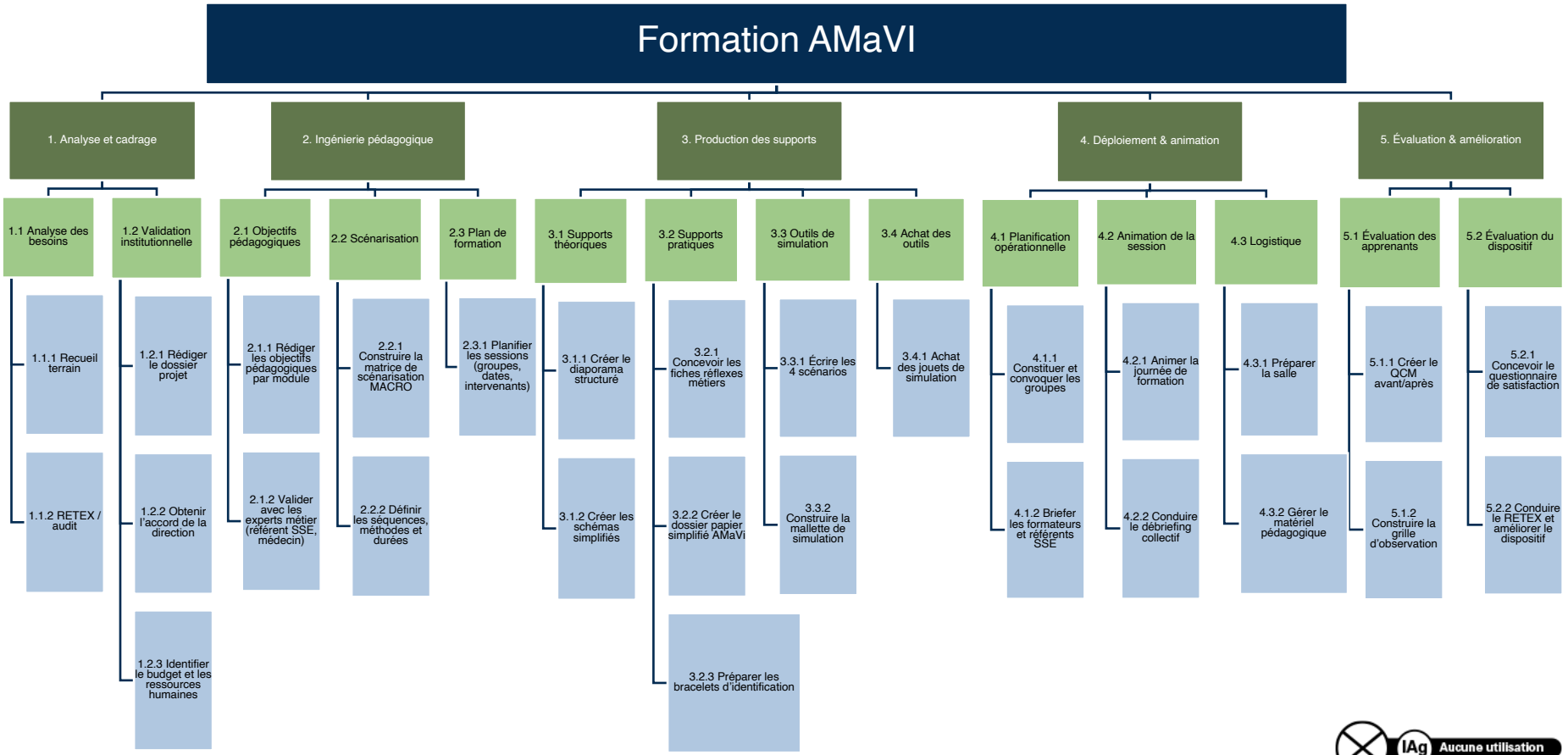
S – Forces	W - Faiblesses
♦ Formation très concrète et immersive. ♦ Adaptée au terrain ♦ Approche interprofessionnelle ♦ Utilisation d'outils opérationnels : fiches réflexes, matériel réel (bracelets, dossier papier). ♦ Appui sur un cadre réglementaire fort ♦ Basée sur des RETEX ♦ Formation standardisant des pratiques	♦ Disponibilité limitée du personnel. ♦ Difficulté à réunir toutes les professions en même temps ♦ Turn-over important = nécessité de répéter souvent ♦ Charge de travail supplémentaire pour les formateurs ♦ Fatigue, surcharge des équipes pouvant limiter l'engagement ♦ Simulation sur table (moins immersive qu'une simulation haute-fidélité)
O - Opportunités	**T - Menaces**
♦ Amélioration globale de la qualité et sécurité des soins ♦ Développement d'une culture de gestion de crise dans le service ♦ Valorisation des compétences des professionnels ♦ Renforcement du travail en équipe interprofessionnel ♦ Possibilité d'extension à d'autres services ou établissements ♦ Intégration dans les plans de formation institutionnels ♦ Amélioration de la réactivité en situation sanitaire exceptionnelle (SSE)	♦ Contrainte budgétaires (matériel, temps formateur) ♦ Priorités institutionnelles concurrentes ♦ Difficulté à maintenir la formation dans le temps ♦ Turn-over élevé = perte rapide des compétences acquises ♦ Pression d'activité aux urgences (annulation de sessions possible) ♦ Évolution des recommandations, plans = nécessité de mise à jour constante

IAg Aucune utilisation

2. Organisation du projet

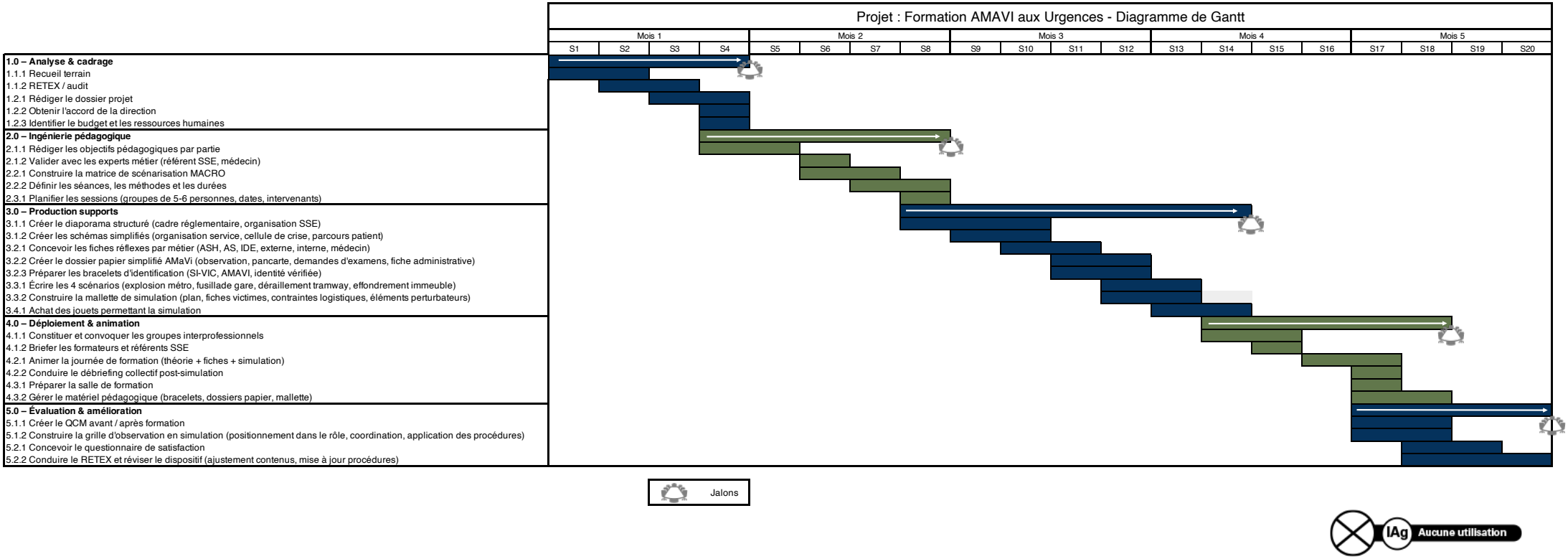
2.1. Work Breakdown Structure (WBS)

Le WBS est présenté dans l'onglet n°5 du fichier Excel « Matrice de Scénarisation - Projet AMaVi »



2.2. Planning – Diagramme de Gantt

Le diagramme de GANTT est présenté dans l'onglet n°6 du fichier Excel « Matrice de Scénarisation - Projet AMaVi »



IAg Aucune utilisation

2.3. Matrice des responsabilités – RACI

La matrice des responsabilité - RACI est présenté dans l'onglet n°7 du fichier Excel « Matrice de Scénarisation - Projet AMaVi ».

Projet : Formation AMAVI aux Urgences - RACI									
Acteurs			Chef de projet	Équipe pédagogique	Référent SSE	Cadre de santé	Cellule formation	Formateurs animateurs	Soignants
Phases	Lots	Tâches							
1	1.1	1.1.1	R	C	C	C	I		C
		1.1.2	R	C	C	C	I		C
	1.2	1.2.1	R	C	C	A	I		
		1.2.2	R		C	A	A		
		1.2.3	R		C	A	A		
2	2.1	2.1.1	RA	R	C	C	I		
		2.1.2	A	R	C	C	I		
	2.2	2.2.1	R	R	C	I	I		
		2.2.2	R	R	C	I	I		
	2.3	2.3.1	R	C	C	A	I	I	I
3	3.1	3.1.1	A	R	C	I	I	C	
		3.1.2	A	R	C	I	I	C	
	3.2	3.2.1	A	R	C	C	I	C	
		3.2.2	A	R	C	C	I	C	
		3.2.3	A	R	C	I	I	C	
	3.3	3.3.1	A	R	C	I	I	C	
		3.3.2	A	R	C	I	I	C	
	3.4	3.4.1	A	R	C	I	I	C	
4	4.1	4.1.1	R	C	C	A	I	I	I
		4.1.2	R	C	C	A	I	R	
	4.2	4.2.1	I	C	C	I	I	R	
		4.2.2	I	C	R	I	I	R	C
	4.3	4.3.1	R		C	A	I	C	
		4.3.2	R	C		I	I	R	
5	5.1	5.1.1	A	R	C	C	I	C	
		5.1.2	A	R	R	C	I	C	
	5.2	5.2.1	R	R	C	C	I	C	
		5.2.2	R	R	R	A	I	C	C

Légende :



- R : Responsible → en français : réalise.
- A : Accountable → en français : autorité.
- C : Consulted → en français : consulté.
- I : Informed →en français : informé

2.4. Plan de charge

Le plan de charge est présenté dans l'onglet n°8 du fichier Excel « Matrice de Scénarisation - Projet de formation AMaVi ».

Projet : Formation AMAVI aux Urgences - Plan de charge						
7 Types de ressources humaines		**148 h Charge humaine totale**		**20 sem. Durée du projet**		
Type de ressource	Ressource	Tâches concernées	Lots impliqués	Qté / sem.	Nb sem.	Total prévisionnel
Humain Pilotage du projet						
x	**Chef de projet** 1 personne	Toutes les tâches (coordination, validation, planification)	L1 L2 L3 L4 L5	~3–4 h	20	**65 h**
Humain Conception pédagogique						
Conception	**Équipe pédagogique** 1–2 personnes	Objectifs, scénarisation, diaporama, fiches réflexes, scénarios, QCM	L2 L3 L5	~4–6 h	14	**56 h**
Expert contenu	**Référent SSE** 1 personne	Validation objectifs, fiches réflexes, scénarios, débriefing	L2 L3 L4	~1–2 h	15	**22 h**
Humain Décision & validation institutionnelle						
Décision	**Cadre de santé** 1 personne	Validation dossier projet, accord session, planification groupes	L1 L4	~1 h	10	**10 h**
Décision	**Direction / cellule formation** 1 personne	Accord institutionnel, budget, information CME	L1 L5	~0,5 h	6	**5 h**
Humain Animation & formation						
Animation	**Formateurs animateurs** 2–3 personnes	Animer les sessions, conduire les simulations, débriefing	L4	~7 h/j	2 j de session	**14 h × 2–3** soit ~35 h
Bénéficiaires	**Soignants / apprenants** Groupes 5–6 pers.	Participation formation, simulation, RETEX	L4 L5	7 h/pers.	1 journée	**7 h/pers.** x
Matériel Ressources matérielles						
Salle	**Salle de formation**	Sessions théoriques + simulation sur table	L4	1 salle	1 j / groupe	**1 journée × nb groupes**
Supports	**Diaporama**	Support théorique modules 1 & 2	L3 L4	1 unité	—	**1 livrable**
Supports	**Fiches réflexes**	6 fiches métier (ASH, AS, IDE, Ext, Int, Méd.)	L3 L4	6 fiches	× nb apprenants	**6 x nb groupes × apprenants**
Outils	**Mallette simulation**	4 scénarios, plan, fiches victimes, contraintes	L3 L4	1 mallette	—	**1 livrable**
Outils	**Bracelets d'identification**	SI-VIC, AMAVI, identité vérifiée	L3 L4	3 types	—	**3 unités**
Outils	**Dossier papier AMaVi**	Observation, pancarte, examens, admin.	L3 L4	1 modèle	—	**1 x / fiche**
Outils	**Figurine**	Figurine + Camion	L3 L4	~30 jeux	—	**1 boîte**
Numérique	**Ordinateur + vidéoprojecteur**	Présentation diaporama, schémas	L4	1 poste	J de session	**x**
Financier Ressources financières (estimatif)						
Temps RH	**Heures chef de projet**	65 h de coordination & conception	L1 → L5	—	—	**65 h valorisées**
Temps RH	**Heures équipe péda.**	56 h de production	L2, L3, L5	—	—	**56 h valorisées**
Impression	**Impression supports**	Fiches, dossiers, checklists	L4	~30 jeux	—	**À chiffrer**
Matériel	**Bracelets & consommables**	Bracelets SI-VIC, AMAVI, vérifiés	L4	~3 u.	—	**À chiffrer**
Matériel	**Figurine**	Figurine + Camion	L4	~30 jeux	—	**À chiffrer**

IAg Assistance majeure

2.5. Analyse des risques

L'analyse des risques est présentée dans l'onglet n°9 du fichier Excel « Matrice de Scénarisation - Projet de formation AMaVi ».

Projet : Formation AMAVI aux Urgences - Analyse des risques						
Risques humains et organisationnels						
	Risque	**Cause**	**P**	**I**	**Criticité**	**Plan d'action**
R01	Indisponibilité du personnel pour les sessions	Activité urgences, gardes, congés	3	3	9	Planifier hors périodes de forte activité ; Multiplier les créneaux
R02	Turn-over des soignants	Rotation des équipes aux urgences	3	2	6	Prévoir des sessions récurrentes ; Intégrer la formation au parcours d'accueil
R03	Résistance au changement	Charge de travail perçue ; Manque de motivation	2	2	4	Communication en amont ; Impliquer les référents terrain ; Valoriser la formation
R04	Difficulté à réunir toutes les professions	Plannings décalés et différents	3	2	6	Constituer les groupes 3 mois à l'avance (comme les plannings) ; Prévoir des remplaçants
R05	Départ du chef de projet	Mutation ; Changement de poste	1	3	3	Documenter toutes les étapes ; Former un suppléant
Risques pédagogiques						
	Risque	**Cause**	**P**	**I**	**Criticité**	**Plan d'action**
R06	Contenu non validé par les experts	Désaccord sur les procédures ; Retard de validation	2	3	6	Impliquer le référent SSE dès la conception ; Prévoir 2 cycles de relecture
R07	Scénarios de simulation non réalistes	Mauvaise estimation des contraintes terrain	2	2	4	Tester les scénarios en amont avec 1 groupe pilote
R08	Objectifs pédagogiques non atteints	Temps insuffisant ; Surcharge cognitive	2	2	4	Évaluation QCM avant/après ; Ajuster les contenus après le groupe pilote
R09	Formateurs insuffisamment préparés	Pas de briefing ; Première animation	1	2	2	Briefing formateur obligatoire
Risques institutionnels et financiers						
	Risque	**Cause**	**P**	**I**	**Criticité**	**Plan d'action**
R10	Non-validation par la direction	Priorités concurrentes ; Contraintes budgétaires	1	3	3	Appuyer sur le cadre réglementaire obligatoire
R11	Budget insuffisant	Réduction des dépenses ; Sous-estimation des coûts	2	2	4	Chiffrer précisément les consommables ; Chercher des financements
R12	Procédures ORSAN modifiées en cours de projet	Mise à jour réglementaire	1	3	3	Assurer une veille réglementaire ; Prévoir une révision annuelle des supports
Risques matériels et logistiques						
	Risque	**Cause**	**P**	**I**	**Criticité**	**Plan d'action**
R13	Salle non disponible le jour J	Double réservation ; Urgence institutionnelle	2	2	4	Réserver 4 semaines à l'avance ; Prévoir une salle de repli
R14	Matériel incomplet ou défectueux	Oubli ; Bracelets manquants ; Panne vidéoprojecteur	2	1	2	Checklist matériel la veille ; Stock de sécurité des consommables
R15	Supports pédagogiques livrés en retard	Charge de travail ; Délai de validation	2	2	4	x

IAg Assistance majeure

Grille de cotation :

- Probabilité (P)

1 = Rare	2 = Possible	3 = Probable

- Impact (I)

1 = Faible	2 = Modéré	3 = Majeur

- Criticité (P x I)

Supérieur ou égal à 4 → Seuil d'alerte

3. Scénario pédagogique

3.1. Scénario général

Le scénario général est présenté dans l'onglet n°2 du fichier Excel « Matrice de Scénarisation - Projet de formation AMaVi ».

Objectif pédagogique	Objectif pédagogique intermédiaire	Thèmes abordés	Synchrone / Asynchrone	Distanciel / Présentiel	Points d'attention (accompagnement, matériel, technologie, documents spécifiques, ressources, supports, etc..)	Intervenants (Compétences)	Durée prévisionnelle
Expliquer les principes du plan ORSAN et du dispositif AMaVi	Définir ORSAN et AMaVi	Définition des termes lié au SSE	Synchrone	Présence	Ordinateur ; Connexion internet	Référent SSE	15 min
	Expliquer le cadre législatif en lien avec le SSE	Législation	Synchrone	Présence	Ordinateur ; Connexion internet	Référent SSE	15 min
Analyser et adapter l'organisation face à une situations sanitaires exceptionnelle (SSE)	Décrire l'organisation nationale en terme de SSE	SSE en France	Synchrone	Présence	Ordinateur ; Connexion internet	Référent SSE	15 min
	Distinguer un plan ORSEC et un plan ORSAN	Les différents plans en France : ORSAN / ORSEC	Synchrone	Présence	Ordinateur ; Connexion internet	Référent SSE	15 min
	Expliquer et distinguer les différents plans ORSAN	Les différents plans ORSAN : AMAVI, REB, EPI-CLIM, ...	Synchrone	Présence	Ordinateur ; Connexion internet	Référent SSE	15 min
	Distinguer les différents plans hospitaliers	Les différents plans dans les hôpitaux	Synchrone	Présence	Ordinateur ; Connexion internet	Référent SSE	15 min
Se positionner dans l'organisation lors d'un déclenchement AMaVi	Repérer et réagir à un déclenchement AMaVi	Volet AMaVi (Afflux Massif de Victimes), procédure de déclenchement d'un AMaVi	Synchrone	Présence	Diaporama structuré	Référent SSE	15 min
	Distinguer et expliquer l'organisation du service lors d'une SSE	Organisation du service, les différentes zones, les équipes, ...	Synchrone	Présence	Diaporama structuré	Référent SSE	15 min
	Distinguer et expliquer l'organisation de l'hôpital lors d'une SSE	Organisation de l'hôpital, implication des services de soins.	Synchrone	Présence	Diaporama structuré	Référent SSE	15 min
	Décrire le rôle de la cellule de crise	Organisation et mise en place de la cellule de crise. Les membres, son rôle.	Synchrone	Présence	Diaporama structuré	Référent SSE	20 min

IAg Assistance limitée

Objectif pédagogique	Objectif pédagogique intermédiaire	Thèmes abordés	Synchrone / Asynchrone	Distanciel / Présentiel	Points d'attention (accompagnement, matériel, technologie, documents spécifiques, ressources, supports, etc..)	Intervenants (Compétences)	Durée prévisionnelle
Expliquer son rôle et celui des autres professionnels lors d'un AMaVi	Décrire les rôles des Agents administratifs (AMA, Secrétaire) lors un AMaVi	Les rôles des AMA, secrétaire et les fiches réflexes	Synchrone	Présence	Fiches réflexes papier	Référent SSE	25 min
	Décrire les rôles des Brancardiers pendant un AMaVi	Les rôles des brancardiers et les fiches réflexes	Synchrone	Présence	Fiches réflexes papier	Référent SSE	15 min
	Décrire les rôles des Agents de Service Hospitalier (ASH) pendant un AMaVi	Les rôles des ASH et les fiches réflexes	Synchrone	Présence	Fiches réflexes papier	Référent SSE	15 min
	Distinguer les différents rôles des Aides-Soignants (AS) pendant un AMaVi	Les rôles des AS et les fiches réflexes	Synchrone	Présence	Fiches réflexes papier	Référent SSE	25 min
	Distinguer les différents rôles des Infirmiers (IDE) pendant un AMaVi	Les rôles des IDE et les fiches réflexes	Synchrone	Présence	Fiches réflexes papier	Référent SSE	25 min
	Décrire les rôles des Infirmière de Pratique Avancée (IPA) pendant un AMaVi	Les rôles des IPA et les fiches réflexes	Synchrone	Présence	Fiches réflexes papier	Référent SSE	15 min
	Décrire les rôles des Externes pendant un AMaVi	Les rôles des externes et les fiches réflexes	Synchrone	Présence	Fiches réflexes papier	Référent SSE	15 min
	Décrire les rôles des Internes pendant un AMaVi	Les rôles des internes, secrétaire et les fiches réflexes	Synchrone	Présence	Fiches réflexes papier	Référent SSE	15 min
	Distinguer les différents rôles des Médecins pendant un AMaVi	Les rôles des médecins et les fiches réflexes	Synchrone	Présence	Fiches réflexes papier	Référent SSE	25 min

IAg Assistance limitée

Objectif pédagogique	Objectif pédagogique intermédiare	Thèmes abordés	Synchrone / Asynchrone	Distanciel / Présentiel	Points d'attention (accompagnement, matériel, technologie, documents spécifiques, ressources, supports, etc..)	Intervenants (Compétences)	Durée prévisionnelle
Appliquer les procédures spécifiques à un AMaVi (tri, identification, organisation)	Analyser les critères de gravité des victimes	Fiche de tri médical	Synchrone	Présence	Fiche de tri médical	Référent SSE	15 min
	Distinguer l'identivigilance habituelle de l'identotovigilance pendant un AMaVi	L'identité SIVIC, identité AMaVi et identité vérifié	Synchrone	Présence	Bracelet d'identification	Référent SSE	15 min
	Associer chaque bracelet à sa fonction	Bracelet SIVIC, bracelet AMaVi et bracelet d'identité vérifié.	Synchrone	Présence	Bracelet d'identification	Référent SSE	15 min
	Utiliser le dossier papier en situation AMaVi	Fiche : Observation médical ; Fiche : Pancartes ; Fiche : IOA ; Fiche : Prélèvement sanguin ; Fiche : Demande d'examen complémentaire ; Fiche : Recueil de données administratifs.	Synchrone	Présence	Dossier papier	Référent SSE	30 min
Analyser une situation complexe en équipe et proposer des actions adaptées	Reconnaître un scénario SSE Appliquer les procédures AMaVi Participer à un exercice simulé	Mise en situation sur table sur l'une des 4 situations SSE déclenchant un AMaVi	Synchrone	Présence	Malette de mise en situation (plan, personnage, ...)	Référent SSE	1h
	Évaluer ses connaissances et proposer des axes d'amélioration	Débriefing global – Évaluation finale – Clôture de formation	Synchrone	Présence	Debriefing de la simulation (points forts / axes d'amélioration)	Référent SSE	30 min
						Total heure	8h15

IAg Assistance limitée

3.2. Scénario détaillé d'une partie

Le scénario détaillé est présenté dans l'onglet n°3 du fichier Excel « Matrice de Scénarisation - Projet de formation AMaVi », ainsi que le scénario de la séance 11, disponible dans l'onglet n°4 du même fichier.

Séance n°	Objectif pédagogique global (l'apprenant est capable de…)	Objectif pédagogique intermédiaire	Thème(s)	Synchrone / Asynchrone	Distanciel / présentiel	Activité(s) du formateur	Activité(s) de l'apprenant	Informations complémentaires sur le déroulement de l'activité (début de consigne, message principal,etc…)	Outils numériques	Moyens et Ressources utilisés (supports, sites, livres, video, etc..)	Processus d'évaluation	Accompagnement / Remédiation	Temps indicatif de la séquence en minutes	Actvité Individuelle / Actvité en groupe	Iconographie type d'activité
11	Expliquer son rôle et celui des autres professionnels lors d'un AMaVi	Décrire les rôles des Assistante médico-administrative (AMA, Secrétaire) lors un AMaVi	Rôle des AMA + fiche réflexe	Synchrone	Présence	Anime les échanges, présente la fiche réflexe, questionne, reformule, apporte des exemples concrets, corrige	Écoute active, participation orale, réflexion en groupe, prise de notes, analyse de situation	Déroulé détaillé : 1. Accroche (2 min) : question ouverte → « Quel est selon vous le rôle d'une AMA lors d'un afflux massif de victimes ? » --> Objectif : activer les représentations 2. Recueil des représentations (3 min) : réponses orales, le formateur note au tableau --> Interaction directe 3. Apports théoriques guidés (5 min) : présentation de la fiche réflexe AMA (missions, priorités, organisation --> Explication + lien avec SSE 4. Illustration concrète (5 min) : exemple d'une situation AMaVi (arrivée massive de patients) --> Mise en contexte professionnelle 5. Mise en activité (5 min) : mini-cas oral → « Vous êtes AMA, que faites-vous en priorité ? » --> Travail collectif, réponses argumentées 6. Correction interactive (3 min) : comparaison avec fiche réflexe + ajustements 7. Synthèse (2 min) : rappel des rôles clés + importance dans la chaîne de prise en charge	PowerPoint	Ordinateur + vidéoprojecteur + diaporama + fiche réflexe AMA papier	Évaluation formative : - Questions orales ciblées - Vérification des réponses au cas pratique - Reformulation par les apprenants	Re-explication + Compléments et ajustement : - Reformulation des notions non comprises - Reprise de la fiche réflexe point par point - Donner un exemple supplémentaire - Questionner individuellement les apprenants en difficulté - Soutien méthodologique (comment lire une fiche réflexe)	25 min	Groupe	



Dans le cadre de la formation, la séance 11 a pour objectif de permettre aux apprenants d'identifier et de mémoriser les rôles des assistantes médico-administratives (AMA) en situation d'afflux massif de victimes (AMaVi), tout en consolidant leurs connaissances sur leurs missions spécifiques.
Cette séance s'inscrit dans le module consacré aux rôles professionnels et s'appuie sur l'utilisation d'une fiche réflexe.

Elle se déroule en présentiel, selon une modalité synchrone, et repose sur une pédagogie active favorisant les interactions entre les apprenants et le formateur. Le formateur anime les échanges, présente la fiche réflexe, questionne les apprenants, reformule les

éléments clés, apporte des exemples concrets issus de situations professionnelles et corrige les propositions des participants. Les apprenants adoptent une posture active, alternant écoute, participation orale, réflexion en groupe, prise de notes et analyse de situations.

La séance débute par une phase d'accroche de deux minutes, durant laquelle le formateur pose une question ouverte : « Quel est selon vous le rôle d'une AMA lors d'un afflux massif de victimes ? ».
Cette étape vise à activer les représentations initiales des apprenants. Elle est suivie d'un recueil des représentations (3 minutes), au cours duquel les apprenants proposent des réponses à l'oral. Le formateur les note au tableau, favorisant ainsi une interaction directe et une première mise en commun des idées.

Un apport théorique guidé est ensuite proposé (5 minutes), basé sur la présentation de la fiche réflexe des AMA. Le formateur explicite les missions, les priorités et l'organisation attendue, en faisant le lien avec les situations sanitaires exceptionnelles.
Une illustration concrète (5 minutes) est ensuite apportée à travers un exemple de situation AMaVi, caractérisée par l'arrivée massive de patients. Cette étape permet de contextualiser les connaissances et de les ancrer dans la réalité professionnelle.
Les apprenants sont ensuite mis en activité (5 minutes) à travers un mini-cas oral : « Vous êtes AMA, que faites-vous en priorité ? ».
Ils travaillent collectivement et proposent des réponses argumentées, favorisant ainsi la réflexion et l'appropriation des contenus.
Une correction interactive (3 minutes) est ensuite réalisée, permettant de comparer les réponses des apprenants avec la fiche réflexe et d'apporter les ajustements nécessaires.

Enfin, la séance se conclut par une synthèse (2 minutes), durant laquelle le formateur rappelle les rôles clés des AMA et leur importance dans la chaîne de prise en charge en situation de crise.
L'évaluation est formative et repose sur des questions orales ciblées, la vérification des réponses au cas pratique ainsi que la reformulation des connaissances par les apprenants.

En cas de difficulté, une remédiation immédiate est proposée : reformulation des notions non comprises, reprise de la fiche réflexe point par point, apport d'exemples supplémentaires, questionnement individualisé des apprenants en difficulté et soutien méthodologique, notamment sur la lecture et l'utilisation des fiches réflexes.

Cette séance, d'une durée totale de 25 minutes, mobilise des supports numériques et matériels tels qu'un diaporama PowerPoint, un ordinateur avec vidéoprojecteur, ainsi qu'une fiche réflexe AMA en format papier. Elle se déroule en groupe et s'inscrit dans une logique d'activités de consultation de ressources.

4. Volet technique

Dans le cadre de cette formation, l'utilisation d'outils numériques s'inscrit dans une volonté de diversifier les méthodes pédagogiques et de favoriser l'engagement actif des apprenants. Ces outils seront mobilisés de manière ponctuelle, en complément des apports théoriques et des mises en situation.

Plusieurs plateformes de quiz interactifs seront utilisées, chacune présentant des spécificités pédagogiques.

- **Google Forms**

Google Forms est un outil de création de questionnaires en ligne permettant de proposer des quiz structurés (QCM, réponses courtes, questions ouvertes).

→ Concept : évaluation formative asynchrone ou synchrone

→ Particularités : correction automatique, feedback immédiat, analyse des résultats.

→ Utilité pédagogique :
- Vérifier les acquis après une séquence
- Identifier les notions non comprises
- Permettre à l'apprenant de s'auto-évaluer

→ Intérêt : outil simple, accessible et adapté à une évaluation individuelle

- **QRuiz**

QRuiz est un outil numérique interactif permettant de proposer des quiz en temps réel via smartphone, tablette ou ordinateur, grâce à un accès rapide par QR code.

→ Concept : apprentissage interactif et évaluation formative en direct

→ Particularités : accès rapide sans création de compte, participation simultanée des apprenants, visualisation immédiate des résultats

→ Utilité pédagogique :
- Vérifier la compréhension en temps réel
- Favoriser la participation de l'ensemble des apprenants
- Identifier rapidement les notions non acquises

→ Intérêt : cet outil permet d'impliquer activement les apprenants, y compris les plus discrets, tout en offrant au formateur un retour immédiat sur les acquis, facilitant ainsi l'adaptation et la remédiation.

- **Mentimeter**

Mentimeter est un outil interactif permettant de recueillir les réponses des apprenants en temps réel lors d'une séance.

→ Concept : interaction synchrone et participation collective

→ Particularités : nuages de mots, QCM, échelles d'opinion, questions ouvertes, réponses anonymes

→ Utilité pédagogique :
- Recueillir les représentations initiales des apprenants

- Favoriser la participation de tous, y compris des plus réservés
- Stimuler la réflexion et les échanges en groupe

→ Intérêt : permet une visualisation instantanée des réponses et facilite l'adaptation du contenu pédagogique en fonction des besoins du groupe

♦ Wayground

Wayground est une plateforme de création de quiz interactifs orientée vers l'évaluation ludique.

→ Concept : gamification des apprentissages
→ Particularités : quiz interactifs, feedback immédiat, interface intuitive
→ Utilité pédagogique :
- Consolider les connaissances
- Dynamiser les séances
- Maintenir l'attention des apprenants

→ Intérêt : outil motivant qui favorise l'implication grâce à une approche ludique

♦ Klaxoon

Klaxoon est un outil collaboratif permettant d'interagir avec les apprenants en temps réel.

→ Concept : pédagogie interactive et collaborative
→ Particularités : sondages, quiz, brainstorming, nuages de mots, travail en équipe
→ Utilité pédagogique :
- Recueillir les représentations initiales
- Favoriser l'expression de tous les apprenants
- Stimuler la réflexion collective

→ Intérêt : encourage la participation active et facilite les échanges en groupe

L'utilisation de ces outils numériques s'inscrit dans une démarche pédagogique active centrée sur l'apprenant.
Elle permet de :

- ♦ Diversifier les méthodes d'apprentissage
- ♦ Renforcer l'interactivité et la participation
- ♦ Mettre en place une évaluation formative régulière
- ♦ Favoriser l'auto-évaluation et la mémorisation
- ♦ Adapter les contenus en fonction des besoins identifiés

Ces outils constituent ainsi un levier facilitant l'engagement des apprenants et l'ancrage des connaissances dans un contexte professionnel.

5. Prototypes

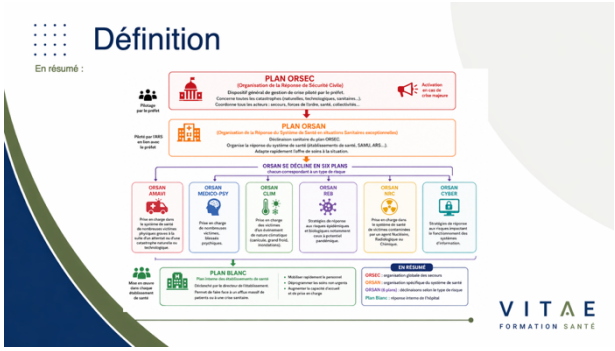
Afin d'illustrer concrètement le dispositif de formation, plusieurs prototypes ont été conçus et sont présentés ci-dessous, selon leur fonction pédagogique.

5.1. Support de présentation

Cette catégorie regroupe des exemples de supports utilisés pour structurer et transmettre les contenus théoriques de la formation. Les diapositives présentées constituent un extrait du diaporama pédagogique et illustrent la manière dont les notions sont abordées auprès des apprenants.











5.2. Outils opérationnels

Cette catégorie présente un exemple d'outil directement mobilisable en situation professionnelle. La fiche réflexe proposée illustre le type de support mis à disposition des apprenants pour faciliter la prise de décision en situation de crise.

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IDE PLAN AMAVI - N° TEL

CHASUBLE BLEU

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

☐ Prévenir les agents administratifs de l'accueil **N° TEL** et l'agent de sûreté **N° TEL**
→ Si pas de réponse téléphonique, se déplacer pour les prévenir oralement.
☐ Composer le **N° TEL** et demander l'affectation immédiate de **2** brancardiers aux urgences.
→ *Remettre la fiche réflexe aux brancardiers à leur arrivée dans le service*

2

☐ Ouvrir la mallette **« AMaVi »** + Mallette **« Chasubles »**
☐ Afficher le plan des urgences
☐ Désigner les rôles et donner les fiches réflexes comme suit :
1 – Désigner **1 AS « AMaVi » ET 1 Externe**
2 – Désigner **2 ASH « renfort-administratif »**
3 – Désigner **1 AS « Identitovigilance »**
→ *Ouvrir malle « AS IDENTITOVIGILANCE »*
→ *Prendre les pochettes « Dossier patient »*
→ *Déposer les dossiers à l'accueil.*
4 – Désigner **1 IDE UA (SAUV)**
5 – Désigner **1 IDE UR (Zone 2A)**
6 – Désigner **1 IDE Impliqué (Zone 1)**
7 – Désigner **1 IDE Zone transitoire (Zone 2B)**
8 – Désigner **1 AS par zone (UA, UR, Transitoire)**
9 – Désigner **1 ou 2 IDE IOA**
10 – Désigner **1 AS LP (N° TEL)**
11 – Désigner **1 IDE LP (N° TEL) + 1 ASH LP (N° TEL)**
13 – Désigner **1 IPA (N° TEL)**
14 – Désigner **1 IDE psy (N° TEL)**
15 – Appel **Secrétaire (N° TEL) ET AMA (N° TEL)**





3

☐ Prévenir les cadres du service :

En semaine	Weekend / Jour férié	Nuit
NOM DES CADRES DE SANTE N° TEL / N° TEL PERSONNEL	Cadre de garde N° TEL PUIS CADRE DU SERVICE	Cadre de nuit N° TEL

4

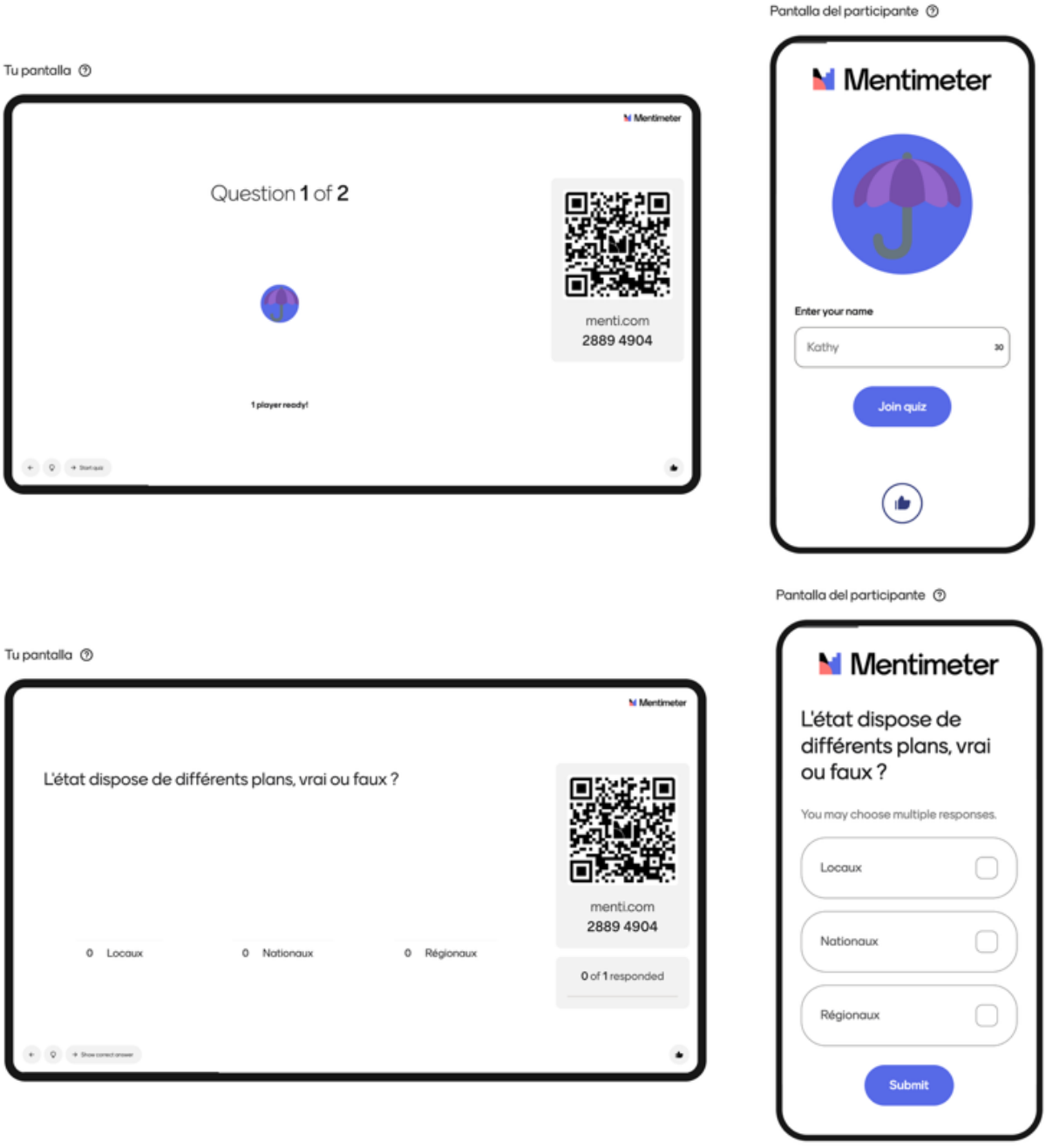
☐ Transmettre ses patients en cours de prise en charge à l'IDE zone transitoire
☐ Contrôler le port de la chasuble + pochette avec matériel par tous selon la zone de soins :
Impliqués : vert ; Urgences Relatives : orange ; Urgences Absolues : rouge
*Les médecins et internes doivent porter une chasuble « **Médecin** »*
☐ **Contrôler la présence du matériel dans chaque zone (registre, paper board, roll).**
☐ Appeler en renfort les IDE selon les effectifs prévus, répartir les effectifs paramédicaux + DECT selon le tableau ci-joint et l'écrire sur le plan
☐ Afficher la feuille d'émargement des renforts à l'accueil administratif du SAU, avec l'heure d'arrivée
☐ Dès l'arrivée d'un encadrant paramédical du SAU, lui faire un état des lieux et se positionne en zone 2 pour prendre en charge les **patients hors AMaVi.**

5.3. Outils d'évaluation et d'interaction – Les quiz

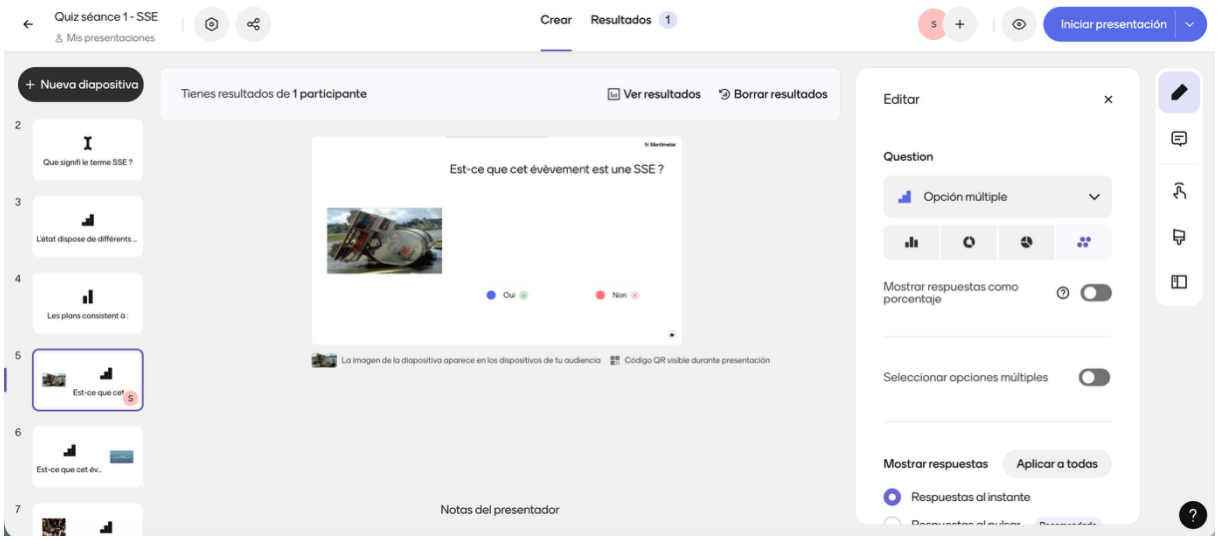
5.3.1. Mentimeter

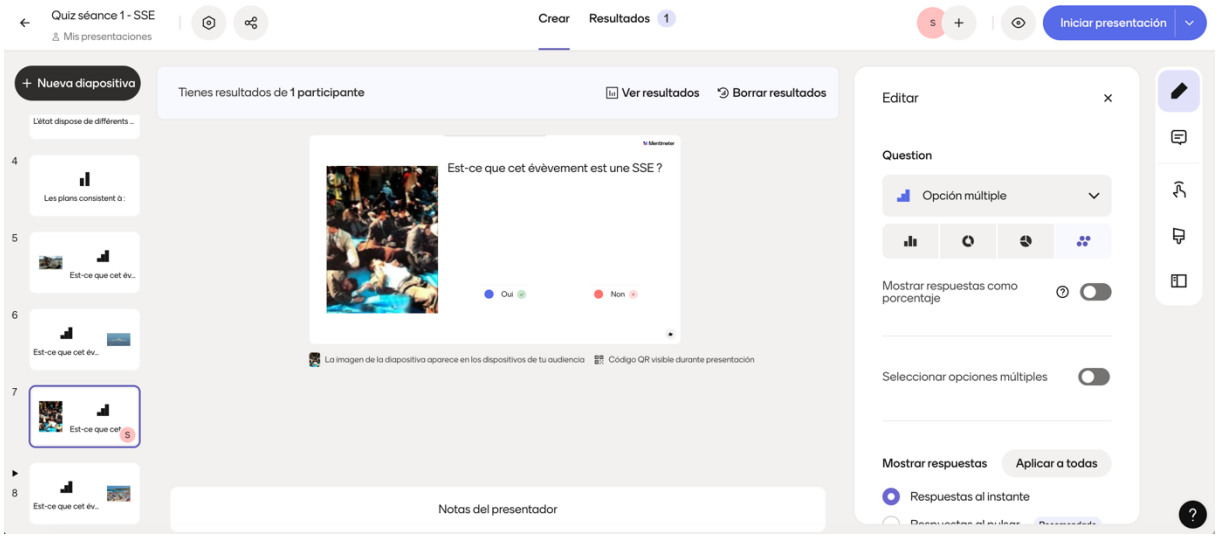
L'outil Mentimeter ne permettant pas le partage direct d'un prototype, des captures d'écran sont présentées afin d'illustrer son utilisation. Celles-ci montrent à la fois l'interface du formateur et l'affichage sur les smartphones des apprenants.

→ Capture d'écran lors du lancement du quiz :



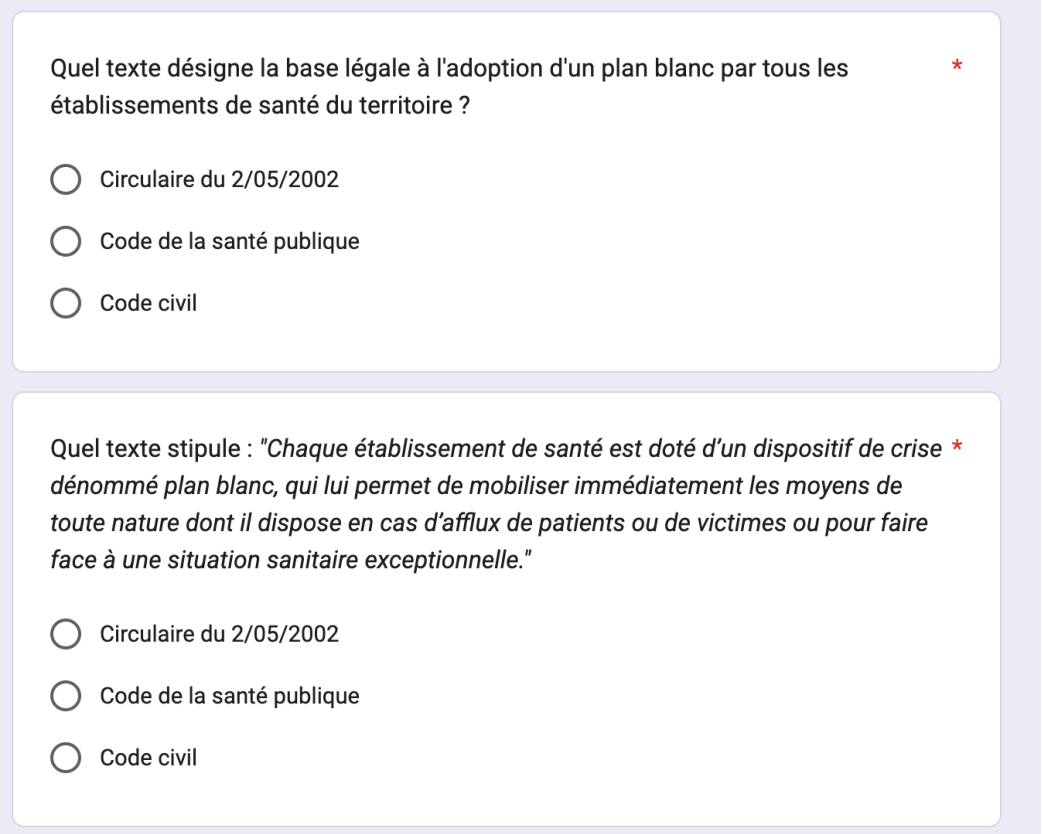
→ Capture d'écran du quiz (côté création) :





5.3.2. Google Form

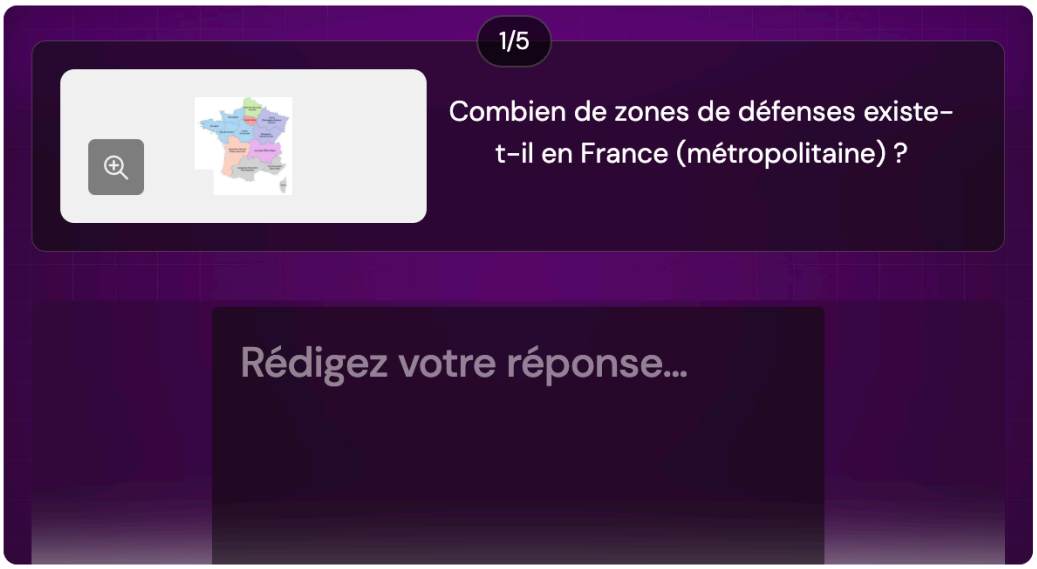
→ Capture d'écran du questionnaire :



Le questionnaire complet est accessible via le QR code ci-dessous :

5.3.3. Wayground

→ Capture d'écran du quiz (aperçu des formés) :

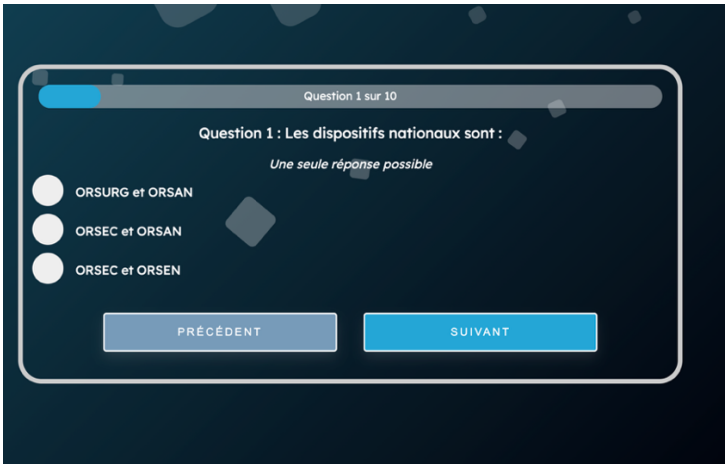


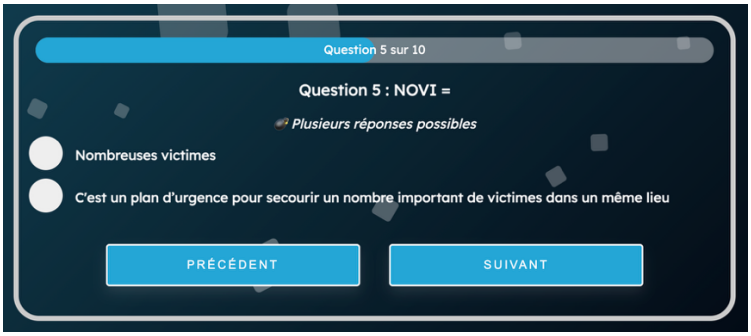


Le quiz complet est accessible via le QR code ci-dessous :

5.3.4. QRuiz

→ Capture d'écran du quiz (aperçu des formés) :



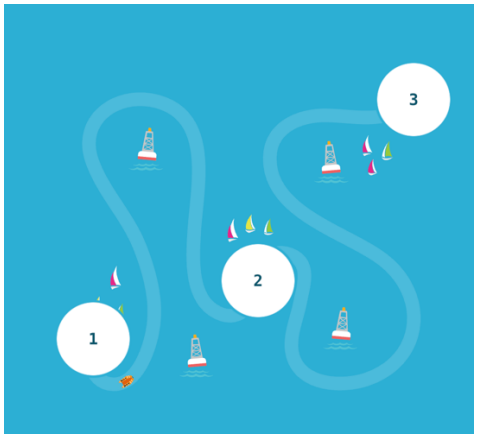




Le quiz complet est accessible via le QR code ci-dessous :

5.3.5. Klaxoon

→ Capture d'écran du quiz :







Le quiz complet est accessible via le QR code ci-dessous :

5.4. Support de simulation

Cette catégorie regroupe les éléments matériels nécessaires à la mise en œuvre des simulations. Elle comprend notamment des supports tels que des figurines, des véhicules miniatures, un plan du service ou encore des calques, permettant de représenter et de mettre en scène des situations réalistes.

→ Des figurines (type Playmobil® ou LEGO®), ainsi que des véhicules de secours, seront mobilisés comme supports pédagogiques de simulation, afin de matérialiser les acteurs, de renforcer le réalisme des situations et de favoriser la projection des apprenants.



→ Un plan vierge du service sera mis à disposition, accompagné de calques de couleur permettant de représenter les différentes zones d'organisation.



6. Conclusion

Face à la recrudescence d'événements à fort impact collectif, tels que les attentats comme ceux du 13 novembre 2015, ou contre Charlie Hebdo, mais aussi des catastrophes majeures comme l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001, la prise en charge d'un afflux massif de victimes (AMaVi) constitue aujourd'hui un enjeu central pour les services d'urgences. Ces situations, par nature imprévisibles et complexes, nécessitent une organisation rigoureuse, une coordination optimale et des professionnels capables d'agir rapidement et efficacement dans un contexte de forte pression.

Le projet de formation présenté s'inscrit pleinement dans cette réalité opérationnelle. En ciblant spécifiquement le dispositif AMaVi, il vise à renforcer la compréhension des rôles, l'appropriation des procédures et la capacité d'adaptation des équipes face à ce type de crise. L'approche pédagogique, fondée sur l'interprofessionnalité et la simulation, s'appuie également sur l'utilisation d'outils numériques interactifs et d'outils concrets, tels que les fiches réflexes, permettant de faciliter l'appropriation des contenus et leur mobilisation rapide en situation réelle.

Les retours d'expérience récents ont mis en évidence des besoins persistants en matière d'organisation, de communication et de gestion du stress. Dans ce contexte, la formation AMaVi apparaît comme une réponse indispensable pour sécuriser la prise en charge des victimes, fluidifier les parcours et renforcer l'efficacité collective.

Au-delà des compétences techniques, ce dispositif contribue à développer une culture commune de gestion de crise, indispensable pour faire face aux enjeux actuels du système de santé. Il permet ainsi aux professionnels de mieux se situer, de coopérer efficacement et d'intervenir de manière coordonnée lors de ces situations.

Ainsi, former les équipes à l'AMaVi ne relève plus uniquement d'une obligation réglementaire, mais constitue une nécessité stratégique pour garantir une réponse adaptée, efficiente et sécurisée face aux crises sanitaires et événementielles contemporaines.

7. Glossaire

- **AMA** : Agent Médico-Administratif
- **AMaVi** : Afflux Massif de Victimes
- **AS** : Aide-Soignant
- **ASH** : Agent de Service Hospitalier
- **EPI-CLIM** : Épidémies et situations climatiques extrêmes
- **GANTT** : Diagramme de Gantt
- **IDE** : Infirmier Diplômé d'État
- **MEDICO-PSY** : Médico-psychologique
- **NRB** : Nucléaire, Radiologique, Biologique
- **ORSEC** : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
- **ORSAN** : Organisation de la Réponse du Système de Santé en Situations Sanitaires Exceptionnelles
- **QCM** : Questionnaire à Choix Multiple
- **RACI** : Responsible, Accountable, Consulted, Informed
- **REB** : Risque Épidémique et Biologique
- **RETEX** : Retour d'Expérience
- **SI-VIC** : Système d'Information pour le suivi des Victimes
- **SSE** : Situation Sanitaire Exceptionnelle
- **WBS** : Work Breakdown Structure ou Structure de découpage du projet

VITAE

FORMATION SANTÉ



MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

EXPERTISE
HUMAIN
EXCELLENCE

NOTRE ENGAGEMENT :
Une démarche de formation centrée sur l'humain, fondée sur l'expertise, animée par l'excellence.

Au service des **équipes de santé**. Pour des **équipes prêtes** à tous les **défis**.

ANTICIPER | **COORDONNER** | **AGIR**

INSPE – SORBONNE UNIVERSITÉ
MASTER 1 – MEEF PIF IFMN

- UE 1 : Concevoir et gérer un projet de formation

- Auteur : Giovanni SILVETTI
Sous la guidance de M. G. SINGEOT